



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مني محمد محمد حسان
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : امبابه
رقم البطاقة : 25601271900307 رقم التليفون : 01207737793
العنوان : ~
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-01-1956 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى محمد محمد حسان National ID: 25601271900307	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



الى من يهمه الامر / مستشفى جوستاف روسي

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة الى قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ، والذي يتضمن بوجوب خضوع المقيمين بمحافظات التطبيق اجباريا بالمنظومة وفقا لمحل الاقامة ببطاقة الرقم القومي داخل احدي محافظات التطبيق، وبالإشارة الى بدء التشغيل الفعلي (2022\7) لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة (اسماعيليه)

برجاء التفضل بالعلم بأنه قد تم الاستعلام عن بيانات المواطن / منى محمد محمد حسان تحمل بطاقة الرقم (25601271900307) المرفقه والتي قد تم اصدارها في تاريخ 2022\4 بمحل الاقامة في محافظة الجيزه بناء علي ما سبق في ان المستفيد المذكور من غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



السيد أ.د / مدير عام المجالس الطبية

تحية طيبة وبعد
كشف حساب

علاج على نفقة الدولة

بيان بنفقات المريض / منى محمد محمد

عن الفترة من ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٦ الى ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٦

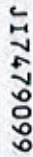
البيان	رصيد القرار	قيمة المنصرف
الرصيد	١ - - -	
اقامة	0	
كشف	0	
اشراف طبي	0	
اشعه (رنين - مقطعية - اخرى)	0	
تحاليل طبية	0	
مستلزمات	0	
علاج متنوعه (بنك دم / علاج)	0	
الادويه	0	
المتبقي		٢٠٠

المراجع
الطبيب



الموظف المختص

Dms





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



٢٤١١
٢٠٢٢

A-Patient ID:

1- Name : علي محمد محمد حسن

2-ID number: 25601271900307

Sex:

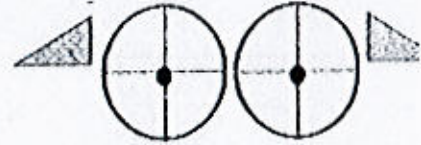
MDT form

3- Medical number:

83105510

Female

Patient Age : 67 Y



Family history

-VE

Phone

01207737793

BMI

NRS Score

GROUP

marital status

Menopausal status

POST

Co morbidity

HCV+VE,,HTN,,DM,,H/O CARDIAC CATHETRIZATION

Date of MDT

12/26/2022

☒ REASON OF MDT

PO

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CTCAP11/2022-->FREE

BX:

RT IDC GII WITH
SCIS

IHC:

ER:

8/8

PR:

8/8

Her 2 Neu :

-VE

KI67 :

5

T

1 (1.5 cm)

N

0

M

0

Sonomammography

10/2022 RT LIQ SUSPICIOUS MASS BIRADS 4C

Recommendations:

RT BREAST MASS BCS+ SLNB

IDC GII

SUPERIOR AND EXTRA SUPERIOR MARGINS ARE INVOLVED BY DCIS

FREE RESECTED MARGIN

LN 0/5 PT1 PNO

MDT OUTCOME & PLAN

for wider excision

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

about:blank



Patient Name	: الأستاذ / منى محمد محمد حسن جاد	Request No.	: 13002565
Patient No.	: 25601271900307	Request Date	: 29/11/2022
Path No.	:	Verification Date	: 18/12/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - ميلارد
Age	: 66 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data :

Right breast mass

Nature of specimen:

breast conservative surgery & SLNB specimens collected at 29/11/22

Gross examination:

1) Sector of mammary tissue 6x6x2 cm with no covering skin , serial cuts revealed ill defined firm mass measured 1.5 x0.9x0.5 cm, located 0.1 cm from least superior and inferior margins

2)SLNB:Fibrofatty tissue piece measured 3.5x2.5 cm enclosing 5 nodules up to 1 cm

3)Extra inferior margin:: Fibrofatty tissue pieces measured 3x3 cm and 4x4 cm , free of gross indurations

4)Extra superior margin:: Fibrofatty tissue piece measured 5x4x1 cm and , free of gross indurations

-Frozen section :

-Superior margin shows :DCIS with free other margins

-Lymph nodes :Free SLNs (0/5)

Microscopic examination: :

• Histological type:Invasive duct carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Ductal carcinoma in situ: focal

• Lymph node involvement:Free (0/5)

• Resection Margins:

-Superior and extra superior margins are involved by DCIS confirmed by IPT (P63&Calponin)

-Free other resected margins

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 19/12/2022 09:43:41

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذ / منى محمد محمد حسان جاد :

Request No. : 13002565

Patient No. : 25601271900307

Request Date : 29/11/2022

Path No. :

Verification Date : 18/12/2022

Sex : Female

Financial Category : اورام دار السلام - مبادرہ

Age : 66 Y

Department : Out Patient

Referreing Doc :

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:

Right breast mass, breast conservative surgery & SLNB specimens :

- Invasive duct carcinoma Grade II
- Superior and extra superior margins are involved by DCIS
- Free other resected margins
- Lymph nodes :Free (0/5)
- Stage : pT1b , pN0

Prof. Gamal Abdelatty

Dr. Esraa Magdy

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date: 19/12/2022 09:43:41

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Patient Name: Mona Mohamed Mohamed Hassaan Gad	Date : 24/10/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 66 Year(s)
Medical ID: 2410	Pat. ID: 21929

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Report:

- ACR B
- Right Breast:
 - LIQ dense irregular mass lesion is seen at 4 cm from the nipple. Corresponds by U/S to (4 o'clock) irregular isoechoic non-parallel mass measuring 20 x 15 mm.
 - Normal skin thickness and nipple areola complex.
 - Dilated retro-areolar ducts.
 - No pathological right axillary LNs
 - No pathological enlarged infra or supraclavicular lymph nodes.
- Left Breast:
 - LOQ paraareolar asymmetric density is seen corresponding to dilated ducts and small cysts. No suspicious contents.
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex .

Opinion:

- Right breast LIQ highly suspicious mass (BIRADS 4c) for histopathological examination .
- left breast LOQ para-areolar focal area of fibrocystic changes (BIRADS 3), for follow up.

Signature Dr. Peter Nashat

24/10/2022 2:03 PM



Patient's Name:

MONA MOHAMED MOHAMED

Date:

2026-04-23

Referred by:

Prof.Dr.

Hospital:

Goustave Rousesey International Egypt

**LEFT DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH RESOLUTION
SONOGRAPHY REVEALED:**

CLINICAL SUMMARY:

Right MRM

FINDINGS:

LEFT BREAST:

Fairly dense fibro-glandular densities, (ACR b).
No spiculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
Complimentary **US** demonstrated no solid or cystic lesion, only retroareolar
mildly dilated anechoic ducts reaching 3mm.
Benign and vascular calcifications are also noted.
Normal skin/nipple/areola complex.
Non-specific axillary nodes.

RIGHT MASTECTOMY BED.

Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
Clear left axilla, and no pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

CONCLUSION:

- Left breast (BIRADS 2): mild duct ectasia and benign calcifications
- Clear right mastectomy bed

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Patient Name: MONA Mohamed MOHAMED	Date : 25 /06 /2026
Exam : ULTRASOUND ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION

REVEALED:

- Liver:-
- Average size (14cm at Rt MCL) normal parenchymal echo pattern
- Portal vein is patent and not dilated. No IHBRD

Gall Bladder:-

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen:-

- Average in size 10cm , homogenous texture with no focal lesions , normal splenic veins diameter.

Kidneys:-

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: no gross masses

No ascites

Urinary Bladder:-

- Not distended enough however no stones or diverticular out pouching
- Uterus and adnexal
average size , with fundal exophytic mass lesion measuring 3.3 x3.3 cm , associated notable arcuate calcifications seen.
- Endometrial thickness 6.8 mm
- No ovarian or adnexal solid or cystic masses

Opinion:

- Fundal uterine fibroid.
- Endometrial increased thickness for TVUS
- Much colonic gaseous distention

Dr Mahmoud Ashour

Dr Abubakr Hejazi MSc FEBR

Patient's Name:

MONA MOHAMED MOHAMED

Date:

2026-04-23

Referred by:

Prof.Dr.

Hospital:

Goustave Rousesey International Egypt

**LEFT DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH HIGH RESOLUTION
SONOGRAPHY REVEALED:**

CLINICAL SUMMARY:

Right MRM

FINDINGS:

LEFT BREAST:

Fairly dense fibro-glandular densities, (ACR b).
No spiculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
Complimentary **US** demonstrated no solid or cystic lesion, only retroareolar
mildly dilated anechoic ducts reaching 3mm.
Benign and vascular calcifications are also noted.
Normal skin/nipple/areola complex.
Non-specific axillary nodes.

RIGHT MASTECTOMY BED.

Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
Clear left axilla, and no pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

CONCLUSION:

- Left breast (BIRADS 2): mild duct ectasia and benign calcifications
- Clear right mastectomy bed

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Patient Name: MONA Mohamed MOHAMED	Date : 25 /06 /2026
Exam : ULTRASOUND ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION

REVEALED:

Liver:-

- Average size (14cm at Rt MCL) normal parenchymal echo pattern
- Portal vein is patent and not dilated. No IHBRD

Gall Bladder:-

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen:-

- Average in size 10cm , homogenous texture with no focal lesions , normal splenic veins diameter.

Kidneys:-

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: no gross masses

No ascites

Urinary Bladder:-

- Not distended enough however no stones or diverticular out pouching
- Uterus and adnexal
average size , with fundal exophytic mass lesion measuring 3.3 x3.3 cm , associated notable arcuate calcifications seen.
- Endometrial thickness 6.8 mm
- No ovarian or adnexal solid or cystic masses

Opinion:

- Fundal uterine fibroid.
- Endometrial increased thickness for TVUS
- Much colonic gaseous distention

Dr Mahmoud Ashour

Dr Abubakr Hejazi MSc FEBR